

RECURSO CÍVEL Nº 5062918-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRENTE: TATIANE SILVA MARTINS ROSA (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ENUNCIADO 12 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO OFERECIDO PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, com a respectiva manutenção da sentença. Condeno a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Publique-se. Intime-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5062918-43.2024.4.02.5101

510015694055 .V7

RECURSO CÍVEL Nº 5062918-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRENTE: TATIANE SILVA MARTINS ROSA (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença, *verbis*: (evento 81, SENT1)

"Trata-se de ação proposta por THAYNA MARTINS DE SOUZA LEOPOLDINO, representada por Tatiane Silva Martins Rosa, em face da UNIÃO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, postulando liminarmente, a condenação das Rés para que propiciem as condições necessárias para sua melhora, com o fornecimento do APARELHO E SSENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE FREE STYLE e MEDICAMENTO VAST 20 MG (30 COMPRIMIDOS). No mérito, requer a confirmação da tutela; bem como, a condenação das rés ao pagamento de R\$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais.

Como causa de pedir, sustenta em síntese, que é portadora de diabetes Mellitus e necessita bomba do aparelho de monitoramento para controle da diabetes, no entanto, não possui condições financeiras para arcar com o custo dos mesmos.

Documentos que instruem a inicial - Evento 1 - anexos 2 a 11 e Evento 20.

Parecer do NAT - Evento 10, acatado pelo Juízo, no sentido de que embora o aparelho FreeStyle Libre® e sensores sejam indicados ao quadro clínico da parte autora, não são imprescindíveis. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS. Em relação ao medicamento Atorvastatina Cálcica (Vast), informa que o mesmo possui registro na Anvisa e é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Esclarece que para o acesso ao medicamento Atorvastatina 20mg disponibilizado no CEAF, a representante legal da Requerente deverá efetuar cadastro junto ao CEAF, comparecendo à Rio Farmes - Farmácia Estadual de Medicamentos Especiais situada à Rua Júlio do Carmo, 585 - Cidade Nova (ao lado do metrô da Praça Onze), de 2ª à 6ª das 08:00 às 15:30 horas, Tel.: (21) 98596-6591/ 96943-0302/ 98596-6605/ 99338-6529/ 97983-3535, munida da seguinte documentação: Documentos pessoais: Original e Cópia de Documento de Identidade ou da Certidão de Nascimento, Cópia do CPF, Cópia do Cartão Nacional de Saúde/SUS e Cópia do comprovante de residência. Documentos médicos: Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização

de Medicamentos (LME), em 1 via, emitido a menos de 90 dias, Receita Médica em 2 vias, com a prescrição do medicamento feita pelo nome genérico do princípio ativo, emitida a menos de 90 dias. Nesse caso, o médico assistente deve observar que o laudo médico será substituído pelo Laudo de Solicitação, avaliação e autorização de medicamentos (LME), o qual deverá conter a descrição do quadro clínico do paciente, menção expressa do diagnóstico, tendo como referência os critérios de inclusão previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde, bem como os exames exigidos no PCDT, quando for o caso.

Evento 43- decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela.

Evento 52 – pedido de reconsideração apresentado pela parte autora.

Evento 61 – mantido o indeferimento da tutela.

Evento 65- o MPF requer nova vista dos autos.

Evento 68 – contestação apresentada pela União.

Embora devidamente citados, o Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro não apresentaram contestações, conforme certificado decurso de prazo no Evento 72

Evento 73 – Replica.

Evento 75 – determinada nova vista ao MPF como requerido.

Evento 79 – manifestação do MPF opinando pela improcedência do pedido.

É o relato do necessário. Decido.

O processamento do presente feito atende às diretrizes da Recomendação do CNJ nº 146 de 28/11/2023.

Por se tratar de matéria eminentemente de direito, passa-se à imediata apreciação do mérito da demanda, na forma do art. 355, I do CPC. Com a réplica, o processo encontra-se maduro para sentença, uma vez que a produção de prova pericial se afigura desnecessária, tendo em vista os documentos carreados nos autos, os quais demonstram de forma inequívoca que a parte autora é portadora da doença mencionada e da necessidade do medicamento postulado.

Inicialmente, saliente-se que o presente feito tramita na Justiça Federal em razão da presença da União Federal no mesmo, chamando, em decorrência disso, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal. Não há que se esquecer que o art. 196 da CF/88 preceitua que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, sendo este aqui entendido não como o ente federativo, mas como Poder Público de Estado, englobando a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Esta interpretação surge em decorrência da norma contida no art. 198, § 1º, da CF/88, que estabelece a formação do Sistema Único de Saúde, financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social dos entes acima mencionados, além de outras fontes. E não há de se olvidar que a competência administrativa material comum é repartida entre os mesmos entes no que tange à prestação de ações de saúde e de assistência pública (art. 23, II, CF/88). Também a jurisprudência vem se inclinando para a formação de um litisconsórcio passivo, conforme pode se ver no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA FIGURAREM NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA.

1. Inexiste ofensa ao art. 535, II, do CPC, quando as questões levadas ao conhecimento do Órgão Julgador foram por ele apreciadas.

2. Recurso no qual se discute a legitimidade passiva da União para figurar em feito cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à manutenção de pessoa carente, portadora de atrofia cerebral gravíssima (ausência de atividade cerebral, coordenação motora e fala).

3. A Carta Magna de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves.

4. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda.

5. Recurso especial desprovido.

(STJ; Resp. 507205/PR; Rel. Min. José Delgado; DJ de 17.11.03,p. 213)

Não por outro motivo, também as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio de Janeiro editaram o seguinte enunciado:

Enunciado 43: A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS.

Também os outros entes federativos (Estado e Município) são legitimados passivos para o feito, tendo em conta os supracitados arts. 23, II e 198, § 1º, ambos da CF/88.

Nesse sentido, confira-se acórdão da 2ª Turma Recursal dos JEFs/RJ, proferido no Recurso nº 0111138-56.2104.4.02.5151/01, julgado em sessão de 10.02.2015, juízo de origem 3º JEF/RJ, Relatora a Juíza federal Itália Maria Zimardi Arês Poppe Bertozzi, com a seguinte ementa:

"MEDICAMENTOS. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTIGOS 196 E 198 DA CRFB/88. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL, ESTADO E MUNICÍPIO. ENUNCIADO 43 TRRJ. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 7º, XIII, DA LEI Nº 8.080/90 E AOS ARTS. 196 E 198 DA CRFB/88. UNIÃO TEM O DEVER DE PRESTAR DIRETAMENTE O MEDICAMENTO CASO COMPROVADO QUE O ESTADO/MUNICÍPIO NÃO ESTEJA FORNECENDO DE FORMA ADEQUADA, DIANTE DO SEU CARÁTER DE GESTORA DO SUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."

Efetivamente em relação ao mérito, é necessário prévio esclarecimento sobre o funcionamento e repartição de competências do SUS.

Como é sabido, a integração das ações e serviços públicos de saúde é posta em operação através de uma rede regionalizada e hierarquizada (art. 198, caput, CF/88), conhecida como Sistema Único de Saúde (SUS), sistema este minuciosamente descrito pela Lei nº 8.080/90. Dentre as várias atribuições postas ao SUS, destaca-se a execução de ações de assistência terapêutica integral (inclusive farmacêutica) e a formulação de uma política de medicamentos (art. 6º, I, "d" e VI da Lei nº 8.080/90).

Como afirmado, o sistema integrado é constituído através de uma hierarquia e, como tal, deve conter funções descentralizadas de avaliação, controle, organização e execução material de serviços.

Ora, o art. 16 da Lei nº 8.080/90 estabelece a competência à direção nacional do SUS, a cargo da União Federal. A partir da leitura de seus 19 incisos, podemos verificar que compete basicamente à União a direção e coordenação geral dos programas a serem desenvolvidos. Assim, cabe-lhe formular e implementar políticas ligadas ao meio ambiente; saneamento básico (inc. II); definir e coordenar sistemas de assistência de alta complexidade; de vigilância epidemiológica e sanitária (inc. III); administrar e ser órgão gestor de várias políticas públicas de saúde (incs. VIII, X, XVI, XVIII, dentre outros). Em suma, o art. 16, XVII sintetiza basicamente a atribuição da direção nacional, que é a de acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais.

Por outro lado, se analisarmos as competências postas às direções estaduais e municipais (arts. 17 e 18), constataremos basicamente funções de execução. Chama-se, aqui, atenção ao art. 18, incisos I (que chama responsabilidade ao Município para execução dos serviços públicos de saúde) e V (em que se vê um dever deferido aos Municípios de execução em favor da política de insumos e equipamento para a saúde).

Vale dizer, na medida em que o SUS preste com eficácia a tutela desejada aos cidadãos, a distribuição de atribuições prevista na própria CF/88 e esmiuçada na Lei nº 8.080/90 deve ser observada, já que tem vistas à otimização da própria prestação da tutela; contudo, a partir do momento em que se verifica uma falha na multicitada tutela, descabe apontar-se as divisões administrativas de atribuições como empecilhos para que seja efetivada a proteção à saúde do cidadão, no caso concreto. Na falha estatal, todos os entes federativos são responsáveis, motivo pelo qual a todos eles deve-se dirigir o comando judicial, já que uma pretensão feita em Juízo realça, por si só, falha na prestação da tutela da saúde, pelas vias administrativas.

Por outro lado, tendo em vista a decisão proferida no julgamento do **RESP nº 1.657.156**, findando a afetação vinculada ao Tema nº 106/ 1ª Seção/STJ, o qual determina os critérios para fornecimento de remédios não contemplados pelo SUS, bem como a presença cumulativa dos requisitos para fornecimento dos medicamentos não contemplados na Portaria nº 2.982/2009 do Ministério da Saúde - Programa de Medicamentos Excepcionais não incorporados, alguns requisitos devem ser objetivamente comprovados de forma cumulativa, para que a parte autora receba o medicamento pleiteado, a saber:

1) Apresentar laudo/receituário médico atualizado, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico/junta médica do SUS que esteja assistindo o (a) paciente/parte autora, da necessidade do medicamento, bem como, a impossibilidade de substituição por medicamento(s) fornecido(s) pelo SUS, caso nele haja alternativa terapêutica;

2) Apresentar comprovação da incapacidade financeira para custeio do(s) medicamento(s) com recursos próprios, exceto se a parte autora estiver assistida pela Defensoria Pública da União;

3) Comprovar que o(s) medicamento(s) possui(em) registro na Anvisa, desde que não haja tal informação em parecer do NAT/SAÚDE.

Conforme esclarecido no Parecer do NAT - Evento 10, embora o aparelho FreeStyle Libre® e sensores sejam indicados ao quadro clínico da parte autora, não são imprescindíveis. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS, senão vejamos:

Diante do exposto, informa-se que o aparelho **FreeStyle Libre®** e sensores apesar de **estarem indicados** para o manejo do quadro clínico da Autora, **não são imprescindíveis**. Isto decorre do fato, de **não se configurar item essencial** em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), **padronizada pelo SUS**.

Quanto à disponibilização de **FreeStyle Libre®** e sensores no âmbito do SUS, **não estão padronizados** em nenhuma lista oficial de insumos para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.

Considerando o exposto, informa-se que o teste de referência preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (automonitorização convencional) **está padronizado pelo SUS para distribuição gratuita** aos pacientes portadores de diabetes *mellitus* dependentes de insulina, pelo Programa de Hipertensão e Diabetes – **HIPERDIA**.

Para o acesso ao glicosímetro ofertado pelo SUS, **sugere-se que a representante legal da Autora compareça a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência**, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação.

Destaca-se que o aparelho **FreeStyle Libre®** **possui registro ativo** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)⁷.

Em relação ao medicamento Atorvastatina Cálcica (Vast), informa que o mesmo possui registro na Anvisa e é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Esclarece que para o acesso ao medicamento Atorvastatina 20mg disponibilizado no CEAF, a representante legal da Requerente deverá efetuar cadastro junto ao CEAF, comparecendo à Rio Farmes – Farmácia Estadual de Medicamentos Especiais, senão vejamos:

No que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado, insta mencionar que **Atorvastatina Cálcica 20mg é disponibilizada** pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)⁸, aos pacientes que se enquadram nos critérios de inclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Dislipidemia: Prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite⁹, e conforme o disposto na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e na Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelecem as normas de financiamento e de execução do CEAF no âmbito do SUS.

➤ **Atorvastatina Cálcica 20mg** é disponibilizada pelo CEAF perfazendo o **grupo 2** do referido componente: *medicamento sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal*^{10,12}.

Para o acesso ao medicamento **Atorvastatina 20mg disponibilizado no CEAF para o tratamento da Dislipidemia estando a Autora dentro dos critérios para dispensação**, e ainda cumprindo o disposto nas Portarias de Consolidação nº 2/GM/MS e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelecem as normas de financiamento e de execução do CEAF no âmbito do SUS, a representante legal da Requerente deverá **efetuar cadastro** junto ao CEAF, comparecendo à Rio Farmes – Farmácia Estadual de Medicamentos Especiais situada à Rua Júlio do Carmo, 585 – Cidade Nova (ao lado do metrô da Praça Onze), de 2ª a 6ª das 08:00 às 15:30 horas, Tel.: (21) 98596-6591/ 96943-0302/ 98596-6605/ 99338-6529/ 97983-3535, munida da seguinte documentação: **Documentos pessoais**: Original e Cópia de Documento de Identidade ou da Certidão de Nascimento, Cópia do CPF, Cópia do Cartão Nacional de Saúde/SUS e Cópia do comprovante de residência. **Documentos médicos**: Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos (LME), em 1 via, emitido a menos de 90 dias, Receita Médica em 2 vias, com a prescrição do medicamento feita pelo nome genérico do princípio ativo, emitida a menos de 90 dias. Nesse caso, o **médico assistente deve observar que o laudo médico será substituído pelo Laudo de Solicitação, avaliação e autorização de medicamentos (LME)**, o qual deverá conter a descrição do quadro clínico do paciente, menção expressa do diagnóstico, tendo como referência os

⁷GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Relação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF disponibilizados pela SES/RJ. Disponível em:

<<https://www.saude.rj.gov.br/comm/code/monstrar/arquivo.php?C=Nj5Ndf%2C>>. Acesso em: 17 out. 2024.

⁸MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Conjunta Nº 8, 30 de julho de 2019. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Dislipidemia: Prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite. Disponível em: <<https://www.gov.br/contctep-brasil/docs/protocolos/pdf/dislipidemia.pdf>>. Acesso em: 17 out. 2024.

⁹Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1554, de 30 de julho de 2013. Disponível em:

<https://brs.saude.gov.br/bo/saudelegis/gm/2013/prt1554_30_07_2013.html>. Acesso em: 17 out. 2024.

¹⁰Ministério da Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2023). Disponível em:

<https://www.gov.br/contctep-brasil/docs/20220128_rename_2022.pdf>. Acesso em: 17 out. 2024.



3



critérios de inclusão previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde, bem como os exames exigidos no PCDT, quando for o caso.

O medicamento pleiteado **possui registro** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e **integra** a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME¹³.

Como já salientado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para o fornecimento do medicamento, eis que sequer comprovou ter diligenciado junto à Secretaria Estadual de Saúde para regularização de seu cadastro para recebimento do medicamento fornecido administrativamente.

Nos presentes autos torna-se dispensável o cumprimento de todos os requisitos.

Também requer a parte autora a condenação da parte ré em danos morais, entretanto, não se verifica, no presente caso, conforme já exposto acima, a existência de qualquer ato ilícito praticado pela ré a ensejar o dever compensatório, decorrente de responsabilidade civil objetiva, de modo que igualmente não resta configurado, in casu, o dano moral.

Também não se verifica a ocorrência de qualquer atividade ilícita praticada pelas rés, mas que tenha desaguado na configuração de um dano injusto suportado pela parte autora, já que a existência de dano indenizável independe necessariamente da existência de ato ilícito, por

evidente, mas que, segundo lição de Celso Antonio Bandeira de Mello, deve ser, neste caso, injusto ou anormal.

Registre-se que o dano moral não se confunde com o sentimento de dor, vexame, frustração, raiva ou sofrimento, tratando-se, ao revés, de uma compensação decorrente de uma lesão à cláusula geral de proteção dos direitos da personalidade ou à violação do princípio da dignidade da pessoa humana, valor máximo de nosso ordenamento jurídico – lesão essa que, tivesse ocorrido no caso concreto, frente a uma situação subjetiva existencial, justificaria a indenização por danos morais pleiteada.

Nesse sentido, destaco a lição de Sergio Cavalieri Filho em sua festejada obra “Programa de Responsabilidade Civil” (Malheiros Editores – 3ª Edição – p.88 e segs.), a seguir transcrita:

“Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...) Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, são situações não tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Ademais, não obstante toda a legislação pertinente a matéria, inclusive de patamar constitucional, há de se entender, principalmente o administrando, que o Administrador Público, para gerir os recursos oriundos da Carta Magna e Legislação infraconstitucional, deve se ater ao juízo de conveniência e oportunidade, inerente ao mister do administrador público e fundamental para a alocação de recursos públicos.

Isto posto, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS**, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Defiro a gratuidade de justiça.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado.

Dê-se vista ao MPF.

Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.”

Requeru a reforma da sentença, para a procedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

Dispõe o Enunciado 13 do CNJ: “*Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)*”.

O NAT emitiu parecer nos seguintes termos: (evento 41, PARECER1)

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

Processo nº 5062918-43.2024.4.02.5101,
ajuizado por **Thayná Martins de Souza
Leopoldino**, representada por **Tatiane
Silva Martins Rosa**.

A Autora, 11 anos (DN: 02/10/2013) é portadora de **diabetes mellitus tipo 1 insulino dependente**, com controle glicêmico insatisfatório, associado a grande **variabilidade glicêmica**, com diversos episódios de **hipoglicemia**, inclusive noturnas em uso de insulina de forma contínua. Assim, foi indicado o **sistema de monitoramento contínuo** (Freestyle® Libre) e o medicamento **Atorvastatina Cálcica 20mg** (Vast®) – tomar 1 comprimido à noite, em uso contínuo (Evento 1_LAUDO8, Página 1; Evento 1_LAUDO9, Página 1; Evento 1_RECEIT10, Página 1).

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do **Diabetes mellitus tipo I**, do Ministério da Saúde, o diabetes mellitus (DM) é uma doença endócrino-metabólica de etiologia heterogênea, que envolve fatores genéticos, biológicos e ambientais, caracterizada por hiperglicemia crônica resultante de defeitos na secreção ou na ação da insulina, que pode evoluir com complicações agudas (hipoglicemia, hiperglicemia, cetoacidose, retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença arterial coronariana, doença arterial periférica e doença cerebrovascular). O tratamento do paciente com DM1 inclui cinco componentes principais: educação sobre diabetes, insulino terapia, **automonitorização glicêmica**, orientação nutricional e prática monitorada de exercício físico¹.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, para atingir o **bom controle glicêmico** é necessário que os pacientes realizem **avaliações periódicas dos seus níveis glicêmicos**. O automonitoramento do controle glicêmico é uma parte fundamental do tratamento e este pode ser realizado através **da medida da glicose no sangue capilar (teste padronizado pelo SUS) ou pela monitorização contínua da glicose (MGC)**. Os resultados dos testes de glicemia devem ser revisados periodicamente com a equipe multidisciplinar e, os pacientes orientados sobre os objetivos do tratamento e as providências a serem tomadas quando os níveis de controle metabólico forem constantemente insatisfatórios. O **monitoramento da Glicemia Capilar (GC) continua recomendado para a tomada de decisões no manejo de hiper ou hipoglicemia, mesmo em pacientes que utilizam monitoramento contínuo**².

Acrescenta-se que a Sociedade Brasileira de Diabetes solicitou a incorporação do Sistema flash de Monitorização da Glicose por escaneamento intermitente para o monitoramento da glicose em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2) (que contempla o dispositivo pleiteado). A solicitação é subscrita pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD), Federação Nacional das Associações e Entidades de Diabetes (FENAD), ADJ Diabetes Brasil e Instituto Diabetes

Brasil (IDB). No presente momento o pedido de incorporação se encontra em trâmite na CONITEC, em fase de análise, **sem posicionamento sobre a incorporação**³.

Cabe ressaltar que o **uso do SMCG não exclui a aferição da glicemia capilar (teste convencional e disponibilizado pelo SUS)** em determinadas situações como: 1) durante períodos de rápida alteração nos níveis da glicose (a glicose do fluido intersticial pode não refletir com precisão o nível da glicose no sangue); 2) para confirmar uma hipoglicemia ou uma iminente hipoglicemia registrada pelo sensor; 3) quando os sintomas não corresponderem as leituras do SMCG^{4,5}.

Acrescenta-se que a monitorização da glicemia capilar necessita de uma pequena gota de sangue que habitualmente é adquirida na ponta do dedo, no entanto, **existem sítios de coletas que configuram alternativas igualmente eficazes e menos dolorosas como: lóbulo de orelha, antebraço e panturrilha**⁶.

Diante do exposto, informa-se que o aparelho **FreeStyle Libre®** e **sensores** apesar de **estarem indicados** para o manejo do quadro clínico da Autora, **não são imprescindíveis**. Isto decorre do fato, de **não se configurar item essencial** em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.

Quanto à disponibilização de **FreeStyle Libre®** e **sensores** no âmbito do SUS, **não estão padronizados** em nenhuma lista oficial de insumos para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.

Considerando o exposto, informa-se que o **teste de referência preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (automonitorização convencional) está padronizado pelo SUS para distribuição gratuita** aos pacientes **portadores de diabetes mellitus dependentes de insulina**, pelo Programa de Hipertensão e Diabetes – **HIPERDIA**.

Para o acesso ao glicosímetro ofertado pelo SUS, **sugere-se que a representante legal da Autora compareça a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação**.

Destaca-se que o aparelho **FreeStyle Libre®** **possui registro ativo** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)⁷.

No que concerne ao medicamento pleiteado **Atorvastatina Cálcica** (Vast®) de acordo com bula⁸, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), está indicado para Pacientes Pediátricos (10 a 17 anos) como um adjuvante à dieta de redução dos níveis de colesterol total, LDL-C e Apo B em meninas pós-menarca e meninos, entre 10 e 17 anos, com **hipercolesterolemia familiar heterozigótica** se, após a realização de um teste adequado de terapia

dietética, os níveis de LDL-C continuarem ≥ 190 mg/dL ou ≥ 160 mg/dL e houver um histórico familiar positivo para doença cardiovascular (DCV) prematura, ou presença de 2 ou mais fatores de risco cardiovascular no paciente pediátrico.

Contudo, nos documentos médicos acostados ao processo, consta informação que a suplicante apresenta **diabetes mellitus tipo 1 insulino dependente**. Deste modo, no que refere à indicação do medicamento pleiteado, cumpre informar que a informação fornecida em documentos médicos não foi suficiente para avaliar a indicação do **Atorvastatina Cálcica (Vast®)** conforme a prevista em bula⁸.

Assim, para uma inferência segura acerca da indicação do medicamento pleiteado **sugere-se a emissão/envio de documento médico atualizado, legível, datado e com identificação do profissional emissor descrevendo o quadro clínico completo apresentado pela Requerente**.

No que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado, insta mencionar que **Atorvastatina Cálcica 20mg é disponibilizada** pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF⁹), aos pacientes que se enquadrem nos critérios de inclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Dislipidemia: Prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite¹⁰, e conforme o disposto na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e na Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelecem as normas de financiamento e de execução do CEAF no âmbito do SUS.

➤ **Atorvastatina Cálcica 20mg** é disponibilizada pelo CEAF perfazendo o grupo 2 do referido componente: *medicamento sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal*^{11,12}.

Para o acesso ao medicamento **Atorvastatina 20mg disponibilizado no CEAF para o tratamento da Dislipidemia estando a Autora dentro dos critérios para dispensação**, e ainda cumprindo o disposto nas Portarias de Consolidação nº 2/GM/MS e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelecem as normas de financiamento e de execução do CEAF no âmbito do SUS, a representante legal da Requerente deverá **efetuar cadastro** junto ao CEAF, comparecendo à Rio Farnes – Farmácia Estadual de Medicamentos Especiais situada à Rua Júlio do Carmo, 585 – Cidade Nova (ao lado do metrô da Praça Onze), de 2ª à 6ª das 08:00 às 15:30 horas, Tel.: (21) 98596-6591/ 96943-0302/ 98596-6605/ 99338-6529/ 97983-3535, munida da seguinte documentação: **Documentos pessoais**: Original e Cópia de Documento de Identidade ou da Certidão de Nascimento, Cópia do CPF, Cópia do Cartão Nacional de Saúde/SUS e Cópia do comprovante de residência. **Documentos médicos**: Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos (LME), em 1 via, emitido a menos de 90 dias, Receita Médica em 2 vias, com a prescrição do medicamento feita pelo nome genérico do princípio ativo, emitida a menos de 90 dias. Nesse caso, o **médico assistente deve observar que o laudo médico será substituído pelo Laudo de Solicitação, avaliação e autorização de medicamentos (LME)**, o qual deverá conter a descrição do quadro clínico do paciente, menção expressa do diagnóstico, tendo como referência os

critérios de inclusão previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde, bem como os exames exigidos no PCDT, quando for o caso.

O medicamento pleiteado **possui registro** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e **integra** a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME¹³.

No que concerne ao valor do medicamento pleiteado, no Brasil para um medicamento ser comercializado no país é preciso obter o registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a **autorização de preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)**¹⁴.

De acordo com publicação da CMED¹⁵, o **Preço Fábrica (PF)** deve ser utilizado como referência quando a aquisição dos medicamentos não for determinada por ordem judicial e os medicamentos não se encontrarem relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013, que regulamenta o artigo 4º da Resolução nº 3 de 2011, e o **Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)** é utilizado como referência quando a compra for motivada por ordem judicial, e sempre que a aquisição contemplar medicamentos relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013.

Assim, considerando a regulamentação vigente, em consulta à Tabela de Preços CMED, a **Atorvastatina Cálcica 20mg (Vast®)** com 30 comprimidos possui preço de fábrica R\$ 68,88 e o preço máximo de venda ao governo R\$ 54,05, para o ICMS 20%¹⁵.

É o parecer.

O parecer do NAT esclareceu que o uso da medicação pleiteada não exclui a aferição da glicemia capilar (teste convencional e disponibilizado pelo SUS) em determinadas situações.

Informou que o aparelho FreeStyle Libre® e sensores apesar de estarem indicados para o manejo do quadro clínico do Autor, não são imprescindíveis.

O Enunciado 12 do CNJ determina a necessidade de demonstração da ineficácia do tratamento do SUS. Nos termos do Enunciado: *"A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)".*

Entende-se que a parte autora não comprovou a ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, nesse aspecto.

O NAT é composto por uma equipe de especialistas em saúde pública e para a emissão do parecer foram utilizados e analisados os documentos juntados pela parte autora.

Quanto ao medicamento Atorvastatina Cálcica (Vast), o NAT informou que o mesmo possui registro na Anvisa e é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

Todavia, a parte autora a parte autora não comprovou ter diligenciado junto à Secretaria Estadual de Saúde para regularização de seu cadastro e, conseqüentemente, o recebimento do medicamento pela via administrativa. Não houve comprovação de negativa do poder público quanto ao fornecimento do medicamento.

Também não se verifica a ocorrência de qualquer atividade ilícita praticada pelas rés que tenha desaguado na configuração de um dano injusto suportado pela parte autora.

Registre-se que o dano moral refere-se à uma compensação decorrente de uma lesão à cláusula geral de proteção dos direitos da personalidade ou à violação do princípio da dignidade da pessoa humana, valor máximo de nosso ordenamento jurídico - lesão essa que não ocorreu no caso em apreço.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, com a respectiva manutenção da sentença. Condene a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Publique-se. Intime-se.